

## TEMA 10.32 • REUMATOLOGÍA

## Artritis Reactiva

PERFIL EUNACOM 1.04.1.010

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Artritis Reactiva** es una inflamación articular aséptica que surge como respuesta inmunitaria a una infección previa en otra parte del organismo, generalmente en el tracto gastrointestinal o genitourinario. Históricamente, cuando se presenta la tríada clásica de artritis, conjuntivitis y uretritis, se denominaba **Síndrome de Reiter**, aunque actualmente se prefiere el término Artritis Reactiva con manifestaciones extraarticulares.

## Definición y Temporalidad

La artritis reactiva forma parte del grupo de las **Espondiloartropatías** seronegativas. Su característica principal es que ocurre tras un periodo de latencia de **1 a 4 semanas** después de la infección desencadenante.

- **Curso clínico:** Es una enfermedad que puede ser prolongada.
- **Pronóstico:** A los 6 meses, aproximadamente el 50% de los pacientes se ha recuperado. Al año, la gran mayoría está libre de síntomas, aunque un pequeño porcentaje puede cronificarse.
- **Impacto:** Puede generar una discapacidad funcional significativa durante los meses que dura el cuadro activo.

## NOTA CLÍNICA

**Fisiopatología:** A diferencia de la **Artritis Séptica**, en la artritis reactiva **no se encuentran microorganismos viables** dentro de la articulación. Es una respuesta inflamatoria mediada por el sistema inmune (asociada frecuentemente al antígeno **HLA-B27**) ante antígenos bacterianos que persistieron tras la infección inicial.

## Manifestaciones Clínicas

## Compromiso Articular

Es la manifestación cardinal y suele presentarse de dos formas: 1. **Oligoartritis asimétrica:** Afecta a pocas articulaciones (habitualmente menos de 4), involucrando tanto pequeñas como grandes articulaciones, con predilección por los miembros inferiores (rodillas, tobillos). 2. **Monoartritis:** No es infrecuente. Aunque suele ser menos explosiva que una infección purulenta, siempre plantea el desafío diagnóstico de descartar una causa infecciosa directa.

## El Síndrome de Reiter (Manifestaciones Extraarticulares)

Se define clásicamente por la tríada: **Artritis + Conjuntivitis + Uretritis**.

- **Compromiso Ocular:**
  - **Conjuntivitis:** Suele ser bilateral, leve y transitoria.
  - **Uveítis** anterior: Ojo rojo profundo y doloroso, similar a otras espondiloartropatías.
- **Compromiso Genitourinario:**
  - **Uretritis:** Puede ser la causa (infección por Chlamydia) o parte de la reacción autoinmune (estéril).
  - **Balanitis Circinada:** Lesiones cutáneas en el glande, caracterizadas por placas serpiginosas con bordes bien definidos. **No es una ETS**, sino una manifestación inmunológica.
  - Úlceras genitales.
- **Otras manifestaciones:**
  - Úlceras orales indoloras.
  - **Entesitis:** Inflamación en los sitios de inserción de tendones y ligamentos (típicamente el tendón de Aquiles o la fascia plantar).
  - Dactilitis (dedos en salchicha).

## PERLA CLÍNICA EUNACOM

**Mnemotecnia clásica (en inglés):** "*Can't see, can't pee, can't climb a tree*" (No puede ver -conjuntivitis-, no puede orinar -uretritis-, no puede trepar un árbol -artritis-).

## Etiología: Agentes Desencadenantes

Los patógenos asociados a la artritis reactiva son principalmente bacterias gramnegativas intracelulares o enterobacterias.

**TABLA 10.32.1: ORIGEN DE LA INFECCIÓN VS AGENTES ETIOLÓGICOS PRINCIPALES**

| ORIGEN DE LA INFECCIÓN             | AGENTES ETIOLÓGICOS PRINCIPALES                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gastrointestinal (Entérico)</b> | <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Yersinia</i> . |
| <b>Genitourinario</b>              | <i>Chlamydia trachomatis</i> .                                                 |
| <b>Otros</b>                       | <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Clostridioides difficile</i> .                |

## ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante una **uretritis** en el contexto de una artritis reactiva, es obligatorio descartar una infección activa por *Chlamydia trachomatis*. Si se confirma, debe tratarse inmediatamente con **Doxiciclina** o **Azitromicina** para erradicar el foco infeccioso, aunque esto no siempre detenga la progresión de la artritis ya desencadenada.

## Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente **clínico**, basado en la historia de una infección previa compatible y el patrón de compromiso articular.

- **Anamnesis:** Buscar antecedentes de diarrea o sospecha de ETS en el mes previo.
- **Examen físico:** Buscar signos de entesitis, balanitis, úlceras orales o compromiso ocular.
- **Laboratorio:**
  - El **HLA-B27** no es diagnóstico por sí solo, pero apoya la sospecha clínica (especialmente en casos de compromiso axial o recurrencias).
  - Reactantes de fase aguda (VHS, PCR) suelen estar elevados.
- **Estudio de Líquido Sinovial:** Es mandatorio realizar una **punción articular** ante una monoartritis para descartar **Artritis Séptica** o gota. En la artritis reactiva, el líquido será inflamatorio pero con cultivos negativos (estéril).

## Tratamiento

A diferencia de otras enfermedades reumatológicas crónicas, el enfoque aquí busca controlar la inflamación aguda mientras el cuadro autolimitado resuelve.

- **Primera Línea (AINES):** Son la base del tratamiento para el manejo del dolor y la inflamación articular. Se utilizan a dosis plenas (ej. Indometacina, Naproxeno).
- **Segunda Línea (Corticoides):**
  - Si no hay respuesta a AINES o el compromiso es muy invalidante.
  - Pueden usarse por vía **oral** o mediante **infiltración intraarticular** (esta última es muy útil en monoartritis persistentes).
  - Tienen una respuesta más rápida que en otras espondiloartropatías.
- **Antibióticos:** Solo están indicados si existe evidencia de una infección activa (ej. uretritis por Chlamydia). No se ha demostrado que el tratamiento antibiótico prolongado trate la artritis en sí.

- **Fármacos Modificadores de la Enfermedad (FAME):** En casos que se vuelven crónicos (más de 3-6 meses), se puede considerar el uso de Sulfasalazina o Metotrexato. Los biológicos (anti-TNF) se reservan para casos refractarios muy severos.

**PERLA CLÍNICA EUNACOM**

Para el EUNACOM, recuerda que la **Artritis Reactiva** es una de las causas más frecuentes de oligoartritis en adultos jóvenes. Siempre que veas un caso de artritis después de una diarrea o una conducta sexual de riesgo, piensa en este diagnóstico.

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM****ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 30 años con monoartritis de rodilla 3 semanas después de una gastroenteritis por Salmonella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artritis Reactiva. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- Artritis que aparece 1-4 semanas post-infección; puede durar meses (50% recuperado a los 6 meses)
- Síndrome de Reiter: artritis reactiva + compromiso ocular (conjuntivitis/uveítis) + compromiso genital (uretritis/balanitis circinada)
- Diferenciar uretritis infecciosa por Chlamydia (tratar con doxiciclina) de uretritis reactiva autoinmune
- Agentes: Chlamydia, Campylobacter, Yersinia, Salmonella, Shigella, C. difficile
- Tratamiento: AINEs (primera línea) + corticoides (segunda línea, a diferencia de otras PEA donde son biológicos)
- HLA-B27 apoya el diagnóstico

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTRITIS REACTIVA)****PREGUNTA 1**

Paciente de 30 años con monoartritis de rodilla 3 semanas después de una gastroenteritis por Salmonella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Artritis séptica
- B) Gota
- C) Artritis reactiva
- D) Artritis reumatoide
- E) Artrosis

**PREGUNTA 2**

Paciente con artritis reactiva y uretritis. ¿Qué debe descartarse antes de atribuir la uretritis al cuadro reactivo?

- A) Infección por E. coli
- B) Infección por Chlamydia trachomatis
- C) Infección por VIH
- D) Infección por gonococo
- E) Cistitis intersticial

**PREGUNTA 3**

¿Cuál es el tratamiento de segunda línea en artritis reactiva que no responde a AINEs?

- A) Fármacos biológicos (anti-TNF)
- B) Metotrexato
- C) Corticoides (oral o intraarticular)
- D) Ciclofosfamida
- E) Rituximab

**RESUMEN: ARTRITIS REACTIVA**

La artritis reactiva es una pelvispondiloartropatía que ocurre 1-4 semanas después de una infección. Se presenta como oligoartritis asimétrica o monoartritis (no tan inflamatoria como la séptica, pero hay que descartarla). Puede durar varios meses: a los 6 meses la mitad se ha recuperado, al año la mayoría. El síndrome de Reiter es la variante con síntomas extraarticulares: compromiso ocular (conjuntivitis, uveítis) y compromiso genital (uretritis, úlceras genitales, balanitis circinada). Es importante diferenciar la uretritis por clamidia (infecciosa, tratar con doxiciclina/azitromicina) de la uretritis autoinmune reactiva. Los agentes etiológicos más frecuentes son: *Chlamydia* (*trachomatis* y *pneumoniae*), *Campylobacter*, *Yersinia*, *Salmonella*, *Shigella* y *Clostridioides difficile*. El diagnóstico es clínico (infección previa + artritis clásica descartando otra causa). El HLA-B27 apoya el diagnóstico. El tratamiento es con AINEs (primera línea) y corticoides (oral o intraarticular) de segunda línea, a diferencia del resto de pelvispondiloartropatías donde la segunda línea son biológicos.